

5 - 03- Les Tumeurs Malignes des Maxillaires - Pr. EL BOUIHI

Le propos de ce jour s'articule autour des tumeurs malignes des maxillaires et le traitement de cette question sera similaire à la question précédente, c'est-à-dire les tumeurs bénignes des maxillaires et la compréhension de celle-ci vous facilitera la compréhension du cours actuel. D'une manière générale, les tumeurs malignes des maxillaires se définissent comme des néoformations malignes qui se développent aux dépens des maxillaires. Ils seront exclus de ce tumeur gingivomaxillaire à point de départ muqueux.

En ce qui concerne le chapitre de rappel, il faut savoir que tout ce que nous avons présenté lors du précédent chapitre est aussi valable pour la compréhension de cette pathologie. Néanmoins, il est intéressant de rappeler quelques notions anatomiques importantes à la compréhension déjà de la symptomatologie en rapport avec les cancers des tumeurs malignes des maxillaires, mais aussi la compréhension et l'intégration de ce qu'on appelle une extension locorégionale et ses répercussions. L'enclos maxillaire est un os central du massif facial qui contracte des rapports intimes avec ce qu'on appelle les confins de la face, c'est-à-dire l'orbite et la fosse infratemporale.

De ce fait, les extensions locorégionales se feront plus ou moins fréquemment vers ces régions avec tout l'impact sur la symptomatologie que ça peut engendrer. La mandibule, quant à elle, joue un rôle important dans la physiologie orale et masticatoire et la gravité orale, ne l'oublions pas, il y a le départ des voyants digestifs supérieurs. Donc il n'est pas rare de voir s'il y a développement d'une tumeur maligne à son niveau, une dégradation importante de cette physiologie orale et masticatoire, mais aussi la possibilité de survenir d'asphyxie et troubles de déglutition.

À ce cadre nosologique les tumeurs malignes des maxillaires, nous avons inclus au début de ce propos des cancers gingivomaxillaire du fait de la présence de cette unité gingivo-alvéolaire. Qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Cela veut dire que au niveau de la cavité orale, la gencive qui est un épithélium de revêtement est directement plaquée à l'os alvéolaire sans stroma mésenchymateux interposé. Et donc certaines tumeurs malignes de la gencive, comme le carcinome épidermoïde de la gencive, a tendance à s'étendre rapidement vers l'os alvéolaire du fait de cette contiguïté anatomique.

Ceci d'une part et d'autre part l'extension au niveau de l'os alvéolaire se fait volontiers à l'intermédiaire de l'alvéole elle-même, donc il y a une voie de dissémination tumorale rapide. Autre notion à ne pas perdre de vue, c'est le fait que la cavité orale soit tapissée de muqueuses qui est truffée de glandes salivaires accessoires qui ont pour rôle une humidification quasi constante de la cavité orale et la gencive ne sort pas, ne fait pas exception. Et donc le développement de cancers à leur niveau, comme ce qu'on vient de dire par rapport à l'unité gingivo-alvéolaire, ont tendance à s'étendre vers l'os maxillaire comme certaines formes cliniques de cancers du palais.

Il en découle de ce qu'on vient de dire sur le plan histologique trois grandes étiologies histologiques des tumeurs malignes des maxillaires. Soit des tumeurs malignes des maxillaires odontogènes à partir de vestiges dentaires, soit tumeurs malignes des maxillaires à partir de cette unité gingivo-alvéolaire ou glandes salivaires accessoires. Et troisièmement des tumeurs malignes des maxillaires développées à partir de constitutions naturelles de l'os.

C'est les tumeurs malignes non odontogènes. Une attention aussi particulière à accorder aux cellules hématopoétiques avec le développement de certains cancers comme des lymphomes. A partir de maintenant je voudrais que vous fassiez une comparaison point par point avec tout ce qu'on a dit par rapport aux tumeurs bénignes des maxillaires.

Puisque sur le plan clinique et radiologique les tableaux sont opposés point par point. Donc on avait dit par rapport aux tumeurs bénignes des maxillaires le tableau clinique était plutôt possy-symptomatique avec un tableau qui est silencieux et insidieux. Au contraire les tumeurs malignes des maxillaires se présentent comme des processus qui sont rapidement expansifs et qui se déclarent volontiers par une complication hémorragique cellulitique par une fracture pathologique ou une complication respiratoire.

Elles s'expriment aussi parfois par une perte spontanée des dents qui deviennent rapidement mobiles et qui sont avulsées spontanément. Elles s'expriment et sont accompagnées de douleurs et de névralgie et c'est des tumeurs qui sont parfois accompagnées d'adénopathie cervicale. Ce qu'il faut retenir c'est que les circonstances de découverte sont plutôt bruyantes.

Sur le plan examen physique le clinicien s'attardera à rassembler des symptômes ou des signes physiques complétant un tableau ou un syndrome tumoral malin clinique qui est composé de masse profonde faisant corps avec le maxillaire, des douleurs ou des névralgies déclenchées ou spontanées, la recherche d'hypoesthésie des territoires du tri-jumeau et l'hypoesthésie dans le cadre tumoral est appelé signe de Vincent. En endobuccal le clinicien recherchera une mobilité dentaire avec saignement provoqué ou spontané. Le syndrome tumoral malin recherchera une tendance à la fixité au plan superficiel et aussi la présence d'adénopathie cervicale surtout quand il s'agit de carcinome ou de lymphome.

En ce qui concerne les moyens d'exploration ou imagerie à l'orthopantomogramme et comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à l'opposition point par point aux tumeurs bénignes des maxillaires, les tumeurs malignes des maxillaires elles s'expriment par un syndrome tumoral malin radiologique qui est composé de limites floues des masses ou de la masse sans l'israël de sécurité avec des corticales qui sont rompues, tendance à l'envahissement des structures en l'occurrence le canal alvéolaire inférieur, la présence de réactions périostées et surtout par rapport aux dents, la notion de dents suspendues avec racines intactes. La TDM cervico-faciale joue un rôle important en l'étude des extensions loco-régionales de ces tumeurs. Elle a une valeur localisatrice et étudie les rapports avec les structures avoisinantes avec une certaine supériorité par rapport aux extensions osseuses.

C'est une véritable dissection anatomique par le biais de l'image. L'IRM quant à elle a une meilleure résolution par rapport aux extensions partielles, une meilleure résolution pour étudier les confins de la face notamment la fosse infratemporelle et la base du crâne. Elle est surtout indiquée pour l'étude de certaines régions récidivantes.

Elle est différenciée de fibroses cicatricielles. D'autres examens peuvent être demandés à la recherche de métastases. Ce sont le TEP-SCAN et la scintigraphie osseuse.

Le diagnostic positif est fortement orienté par la clinique et l'imagerie. Il est confirmé par l'étude histologique une pièce de biopsie osseuse. C'est un document médico-légal puisque le patient peut avoir une tumeur qui nécessite une chimiothérapie sans chirurgie comme les lymphomes par exemple et surtout en vue d'une chirurgie mutilante qui peut intéresser une ou plusieurs régions faciales.

En ce qui concerne les formes cliniques, vous distinguez des stades évolutifs de la tumeur en cédant l'examen clinique et d'imagerie donc qui vont permettre la classification TNM de la tumeur et les formes selon la localisation. Il faut savoir qu'aucune région n'est épargnée de ces tumeurs et toutes les formes cliniques sont possibles. Il y a aussi les formes cliniques compliquées, compliquées de fractures pathologiques, compliquées de cellulite ou d'ostéomyélite, compliquées de compression et au final donc compliquées d'hémorragie qui sont plus ou moins importantes dans une érosion de vaisseaux intra-osseux.

La prise en charge de ces tumeurs ne se conçoit que dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire incluant chirurgien maxillofacial, anatomopathologiste, anesthésiste réanimateur et oncologue radiothérapeute. Idéalement les décisions thérapeutiques passent par des réunions de concertation pluridisciplinaire. Le principe de traitement de ces tumeurs étant une prise en charge carcinologique pour les tumeurs qui nécessitent une prise en charge chirurgicale, la résection tumorale respectera des marges d'excision carcinologiques avec plus ou moins chirurgie des extensions loco-régionales lymphatiques cervicales.

Les sarcomes ne nécessitent pas de chirurgie lymphatique, de curage cervical. Les carcinomes eux nécessitent des curages ganglionnaires et pour certaines tumeurs hématopoïétiques la chirurgie ne s'adresse qu'aux noyaux résistants à la chimiothérapie dans le cadre de debulking. La reconstruction est toujours de mise et le plus souvent un traitement adjuvant de radiochimiothérapie est parfois proposé.

Dans tous les cas l'examen anatomopathologique des tumeurs, le traitement d'une pièce d'excision chirurgicale avec limite d'excision carcinologique est effectué. Le pronostic de ces tumeurs dépend des types histologiques, du stade évolutif local, loco-régional et général, la qualité d'excision et le terrain du patient. Les tumeurs extirpables avec maîtrise loco-régionale et notamment lymphatiques sont de bons pronostics et les tumeurs métastatisées très étendues avec adénopathie métastatique sur un terrain taré sont plutôt de mauvais pronostics.

